①对于肠套叠,先钡灌肠(可以诊断弹簧征、杯口征又有复位作用):超过2天的肠套叠应该急诊手术
②肝脾破裂→急诊手术同时抗休克
③AOSC→急诊解除梗阻降低压力(PTCD、ENBD、胆总管切开减压+T管引流)
④腰椎盘突出若出现了二便障碍(压到了马尾神经)→急诊手术
⑤急性动脉栓塞→急诊手术(球囊导管取栓、切开动脉取栓)

外科学 外科总论

核心精讲·围术期

（性感认识：可与各论结合考）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

①传统:疝囊高位结扎+修补
②最常用:补片+修补亚狮龙,唯一缺点:材料是异物可能引起感染
③小脐没必要,结扎大一窄

一、术前

（一）手术分类　易绞窄已绞窄都要做手术

急诊手术	嵌顿或绞窄腹外疝、急性消化道穿孔、急性完全性肠梗阻、大血管破裂等（要挂了）
限期手术	恶性肿瘤等（要转移了）禁食补液,胃肠减压,最佳修补缝合术
择期手术	良性肿瘤、单纯腹外疝、慢性阑尾炎、胆囊结石等

单纯腹外疝合并COPD/前列腺增生→先处理
COPD/前列腺增生(引起腹内压增高的疾病)
若合并嵌顿/绞窄,则先处理腹外疝

有症状→腹腔镜胆囊切除术
无症状但有123钙瓷慢糖心→腹腔镜胆囊切除术

（二）准备

术前 4 周戒烟戒酒（烟酒死鬼）
脑卒中推迟至少 2 周、最好 6 周（老二牛）

将来时
- 曾有出血:择期手术
- 未有出血:①保肝②红色征/明显脾大/脾亢→预防性断流术

进行时
- 休克→补液
- EVL配合血管收缩剂(生长抑素/奥曲肽、垂体后叶素)、PPI、三代头孢、三腔二囊管;保守无效→childA、B急诊断流术,childC做TIPS

childC级:白富美单干

肝功能 Child C 级（黄疸+腹水）暂时不手术，可 **TIPS**（食管胃底静脉曲张出血）、**TACE**（肝细胞癌）等
（C 级黄水不手术、TIPS/TACE 先过渡）

肾功能严重损害在有效透析时可耐受手术（24h 内）（注意：肝肾对比）
营养代谢:肾衰竭是适应症,肝功能损害是并发症

最短禁食时间：**清饮料 2h、母乳 4h、牛奶 6h、淀粉类固体食物 6h、脂肪等肉类 8h**（清母牛肉粉 24686）
胃排空速度:糖>蛋白质>脂肪

胃肠道手术：预防性用抗生素，术前 1-2 天进流食
大肠手术：预防性用抗生素，术前 **2-3** 天进流食、术前 1 天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）01 23
大肠比较脏

仅以饮食控制糖尿病：**不必**特殊准备
平时口服降糖药：继续服至术前 **1** 天（长效降糖药在术前 **2-3** 天停服）
平时用胰岛素：在**手术日晨**停用（3 长 1 短素当天）
维持血糖在 **5.6-11.2** 的轻度升高状态 无需降到正常值,否则易导致低血糖

高血压继续服用降压药避免戒断综合征，**BP≤140/90**
备皮最佳时间：手术开始前

服用β-R拮抗剂的患者心电图显示有I工度一型房室阻滞,出现了黑蒙,接下来该做什么?
停药(①β-R拮抗剂使用剂量不高②吃了药才出现的症状)

NSAIDs 术前 **2-3** 天（阿司匹林术前 **7** 天）、氯吡格雷术前 **10** 天停用（san、七匹狼、石雷鹏）
血小板＜50 需输血小板（武术）ttsx
复习：再障血小板＜20 立即输血小板（二十大板）；ITP 血小板＜10 立即输血小板（ITP 笔画都有一竖）

二、术后

（一）体位

全麻未清醒：平卧、头转向一侧 防止误吸所致窒息
腰麻：去枕平卧/头低卧位 防止脑脊液漏出导致低颅压性头痛